

* איידס והאכלת תינוקות

- * העברה מאם לתינוק של איידס אחראית לכ- 90% ממקרה ההדבקות
- * סך העברה לאחר הלידה של אמהות עם איידס הוא בערך 30% - 15%.
- * העברה בתוך הרחם אחראית לכ- 10% - 5% מהמקרים;
- * העברה בלידה אחראית ל- 20% - 10% נוספים.
- * הנקה מעלה את רמת העברה מעל הסף המיוחס להדבקות ברחם ובלידה בעוד כ-16% - 10%.

* וירוסים בהנקה

- * עד לא מזמן הודיע ארגון הבריאות (WHO) לאמהות נשאיות HIV להימנע מהנקה אם יש להן אלטרנטיבה אחרת
- * מחקר חדש, שמראה כי שילוב של הנקה בלעדית והשימוש בטיפול תרופתי יכול באופן משמעותי להפחית את הסיכון להעברת נגיף האיידס לתינוקות דרך הנקה.
- * טיפול תרופתי זה לנשים נשאיות איידס בהריון ולילודים מפחית את הסיכון להעברה לאחר ההיריון של איידס בכחצי עד שני שליש.

- * זה מוכח ש- HIV יכול לעבור בהנקה
- * **חלב אם** - חלב האם הוא הנחל עם הנוכחות הנמוכה ביותר של הנגיף
- * מחקר חדש מצא קשר בין הרכיבים של חלב האם ליכולת שלו להשמיד את נגיף האיידס ולמנוע הדבקה דרך הפה, בניגוד למה שסברו עד היום.
- * באותו הזמן, אי הנקה במדינות מתפתחות יכולה להיות קטלנית

* המלצות להאכלת תינוקות

- * כאשר מקובלת האכלה חליפית והיא זמינה כלכלית ופיזית, קיימת ובטוחה, מומלצת **הימנעות** מכל הנקה באימהות עם איידס.
- * בכל מקרה אחר מומלצת הנקה בלעדית במהלך 6 חודשים הראשונים לחיים.
- * כדי למזער את הסיכון להעברת איידס, יש להפסיק את ההנקה מוקדם ככל האפשר, תוך התחשבות בתנאים המקומיים, המצב האינדיבידואלי של האישה והסיכונים בהאכלת חליפית (כולל זיהומים אחרים מאיידס ותת תזונה).
- * אסור להפסיק הנקה מיד. הפסקת הנקה תקיים למשך חודש כאשר הם חייבים להמשיך לקבל ARV במשך שבוע אחרי הפסקת הנקה

- * תינוקות אשר היו בהנקה בלעדית היו בעלי רמת סיכון נמוכה משמעותי להעברה של HIV /
- * תינוקות אשר קבלו תוספת תמ"ל (בנוסף להנקה) היו באותו סיכון כמו תינוקות אשר מעולם לא ינקו.
- * תופעת "הכול או כלום" הזו קשורות למחסום הרירי של המעי, אשר נשמר על ידי הפחתה באנטיגנים ממזון ופתוגנים של המעי.

* הרפס סימפלקס (HSV)

- * וירוס הרפס סימפלקס 'הוא זיהום וירלי נפוץ בבני אדם.
- * HSV סוג 2 ו- HSV סוג 1 הן מחלות המועברות במגע מיני.
- * סוג 1 מתרחש לרוב בפנים ובפה.
- * סוג 2 מקושר באופן תכוף יותר עם זיהום של אברי המין
- * נגעים יכולים להתפרץ בכל מקום בגוף, כולל השדיים או אברי המין, לרוב כתוצאה ממגע ישיר.

* בריאות השד

- * קיימות מספר עדויות שמצב השד כולל מסטיטיס, אבצסים וסדקים בפטמה יכולים להגביר את הסיכון להעברת איידס דרך הנקה,
- * נשים נגועות באיידס אשר מניקות צריכות לקבל סיוע כדי לוודא שהן משתמשות בטכניקת הנקה טובה כדי להימנע ממצבים אלו, אשר צריכים להיות מטופלים הדחופות אם הם קורים.



* הנגעים המוגלתיים והכואבים דמויי השלפוחית של הרפס יכולים להופיע תוך כמה שעות, או עד לעשרים יום לאחר החשיפה.

* לאחר שהנגעים מחלימים, הווירוס ניכנס לשלב רדום ונסוג במצבור תאי העצב הנגוע. לרוב ההדבקות הראשונית היא החמורה ביותר.

* זיהום HSV-2 בילוד לרוב קורה כאשר התינוק עובר דרך תעלת הלידה הנגועה; זיהום בתעלת הלידה אחראי לתחלואה החמורה ביותר בילודים.

* לידה נרתיקית היא בטוחה ברוב הנשים עם היסטוריה של הרפס גניטלי חוזר, אלא אם כן נגעים פעילים קיימים במועד הלידה.



* נשים עם נגעי הרפס על החזה צריכות להימנע מהנקה; נגעים פעילים צריכים להיות מכוסים כדי למנוע מגע עם התינוק היונק.

* בהעדר נגעים על השד תינוק לאם עם HSV-1 אם התינוק בריא, יכול לינוק ולשהות עם האם בחדרה;

* עם זאת, קרצוף בשטיפת ידיים, לבישת חלוק וכיסוי כל הנגעים צריכים להתבצע כדי למנוע הדבקה אפשרית.

* האם לא צריכה להשתמש בכפפות בזמן הנקה.



* האיום הגדול ביותר מזיהום HSV-2 הוא עם ילודים כאשר האם חווה אפיזודה ראשונה של הרפס גניטלי בזמן ההיריון קרוב למועד.

* הדבקות ראשונית משמעותה היא שלאמא אין מספיק נוגדנים אשר יעזרו להגן על התינוק מפני הדבקות.

* שיעור העברה לילוד הוא 50% בהדבקות ראשונית ורק 3%-1% בהדבקות חוזרת.

* ילודים עלולים לחלות בצורה חריפה; עם זאת, מעבר לכמה שבועות ראשונים לחייהם, יש רק מעט השלכות מזיקות.

*** אבִּעְבוּעוֹת רוּחַ/וּרִיצָלָה הרפס זוסטר**

* אם אימא נדבֶקֶת באבִּעְבוּעוֹת זמן הנקָה עליה להמשיך להניק, מכיוון שהנוגדנים שבחלבָה מעניקים חיסון לתינוקָה. חיסון פסיבי זה יכול אפילו לחסוך מהתינוק היונק סימפטומים של אבִּעְבוּעוֹת; אם התינוק נדבֶק, מהלך מחלתו יהיה לרוב מתון.

* סינדרום וריצֵלָה מולד יכול להתרחש כאשר האימא נדבֶקֶת באבִּעְבוּעוֹת בחצי הראשון להריון והוא גורם בעיות קשות לעובר, הכוללות משקל לידה נמוך ובעיות נוירולוגיות.

* במרכיבי חלב אם אין נוגדנים לאבִּעְבוּעוֹת

רציונל	התערבות	בעיה
מספק נוגדנים מגנים לתינוק	לעודד המשך הנקה אלא אם כן יש נגעים על השד.	המצאות HSV בדם
עוזר למנוע הפצת הזיהום	יש להורות לאם לשתוף ידיים ביסודיות בסבון לפני הנקה	הרפס
להימנע מסיכון של הפצה	להזהיר את האם מלגעת בתינוק או בשד אחרי נגיעה בנגעים במקום אחר. להזהיר את האם להימנע מאמבטיה עם התינוק; להשתמש באמצעי זהירות אונברסאליים (צוות ב"ח)	אין נגעים על השד
מונע מגע ישיר של התינוק עם נגעים.	להימנע מנוקה מרשד הנגע; לעודד שימוש במשאבה כדי לשמור על נוחות ואספקת חלב; לאחר כל שימוש לעשות סטריליזציה לחלק המשאבה הבא במגע עם השד.	יש נגעים על השד
שיכון כאבים אפקט מרגיע הסחת דעת	תרופות. מריחת תמיסת בארו על העור דמיון מודרך	כאבים

* אם לתינוק יש נגעים, הוא יכול להיות מבודד עם האם ואין להפריע להנקה.

* חיסון גלובולין לוריִצֵּלָה זוסטר ניתן מוקדם ככל האפשר כדי למתן ולמנוע סימפטומים נוספים של המחלה בלי קשר אם האימא כבר קיבלה אותו בזמן ההיריון.

* אמא אשר מפתחת אבִּעְבוּעוֹת רוּחַ ימים ספורים לפני לידה או שמקבלת את הווירוס תוך 48 שעות לאחר הלידה מהווה מצב רפואי מיוחד ומסובך בעל פוטנציאל מסכן חיים.

* לילוד יש סיכוי לחלות באבִּעְבוּעוֹת רוּחַ בצורה קשה מכיוון שאין לו מספיק נוגדנים מהאם כדי להקל את חומרת המחלה.

* אישה עם וריצֵלָה אשר מאושפזת בבית החולים לצורך לידה מטופלת באמצעי זהירות למחלות נישאות באוויר ומועברות במגע.

* לאחר הלידה, יש לבודד את האם והתינוק מאמהות אחרות.

* נוגדנים מופיעים בחלב תוך 48 שעות מתחילת יציאת הנגעים.

* יש להגן על התינוק ממגע ישיר עם הנגעים של האם.

* ציטומגלוירוס (CMV)

- * CMV הוא סוג נוסף של וירוס הרפס.
- * CMV יכול להימצא בחלב אם ובשתן, ובתעלת הלידה ובלוע, והוא מועבר על ידי מגע קרוב כמו בוירוס הרפס אחרים, הוא נשאר בתאי הנשא לעד.
- * מכיוון ש-CMV יכול להיות מועבר בחלב אם, הוכח שהנקה היא אמצעי חשוב לסיפוק חיסון פסיבי, כביכול חיסון טבעי.
- * למרות שתועדה העברה דרך חלב אם, לא דווחו מחלה רצינית או סימפטומים קליניים ביילודים.
- * הסכנה בהדבקות ב-CMV היא בפוטנציאל העברה לעובר או ילוד מאישה אשר נדבקת לראשונה בזמן ההיריון.

* שלבזת חוגרת

- * אם אין נגעים על השד ניתן להמשיך להניק משני השדים, עם מעט שינוי בתנוחה כדי להימנע ממגע ישיר של התינוק עם הנגעים.



* רובלה (אדמת)

- * למרות שווירוס אדמת יכול להיות מועבר על ידי לימפוציטים בחלב האם לתינוק, אין עדות שהתינוק אשר מקבל אדמת בצורה זו, נהיה חולה. כמו ב-CMV מעבר של נוגדנים אימהיים לאדמת, למרות שברמות נמוכות, הוא בעל תועלת לתינוק בכך שהוא משמש כחיסון טבעי.
- * אם האימא מקבלת חיסון לאדמת לאחר הלידה, התינוק היונק יפתח נוגדנים לאדמת אבל לא יראה סימפטומים של המחלה.

- * כמו בוירוס הרפס אחרים, הוא נשאר בתאי הנשא לעד.
- * פגים, בייחוד אם אינם נשאים, הם בסיכון למחלה חמורה אם הם נדבקים ב-CMV סביר יותר שפגים יונקים יחוו הדבקות סימפטומטית מאשר תינוקות שנולדו במועד.
- * נראה כי פסטור של חלב הורס את ה-CMV הקפאת חלב ב-20 מעלות צלסיוס תוריד את הספירה אך לא מונעת CMV בודאאות; לפיכך פגים צריכים לקבל רק חלב מבנק חלב מתורם שאינו נשא.



* לא נראה כי הנקה מגדילה את שיעור ההדבקות של תינוקות. יתר על כן, באזורים עם תפוצה גבוהה של צהבת B וחשיפה סביבתית, העדר הנקה מציב את התינוק בסיכון גבוה יותר להדבקות במחלה.



* הפסיטיס B

* וירוס צהבת B (HBV) גורם למחלה סיסטמית שמערכת את הכבד.

* HBV לרוב מועבר על ידי מגע עם דם או הפרשות גוף נגועות.

* כ-5 עד 15% מהנשים ההרות עם צהבת B ידביקו את תינוקותיהם לפני תחילת הלידה. עיקר החשיפה מתרחשת בזמן או מיד לאחר הלידה, כך שלטיפול מונע וחיסון בתקופה המוקדמת שלאחר הלידה יש סיכוי מצוין למנוע הדבקה.

* תינוקות אשר נולדים לאמא נשאית צהבת B שכבר נחשפו לדם אימהי, נחל מי שפיר, והפרשות וגינאליות בזמן הלידה, יכולים לינוק. התינוק צריך לקבל חיסון צהבת B (HBIG) תוך 12 שעות מהלידה, ולאחריו סידרה של 3 זריקות של חיסון צהבת: במהלך השבוע הראשון לחיים, בגיל חודש ובגיל 6 חודשים.



המלצה	הדבקות (דרך חלב אם)	החיסון
מותר להניק	נראה לא מועבר בחלב אם	אבעבועות רוח (Varicella-zoster)
אמחות חולות יכולות להניק. יש להימנע ממן חלב אם לפנים של אמחות עם CMV חמור	מכחת	CMV
מותר להניק אם לחיטוק לאם יש HBIG + HBsAg	מכחת	הפטטיס B
מותר להניק אם רמת המגדנים אינה גבוהה. אין דיווח על מקרה של הדבקות של חיטוק מאם דרך חלב אם. יש לבער עורכיה פוטנטית במקרה שהאם סובלת מ-HIV חמור	מכחת	הפטטיס C
מותר להניק אם אין פעמים על השד. להקפיד על שטיפת ידים על מסיכה אם יש פעמים בחלל הפה או באברי יחסי.	נראה לא מועבר בחלב אם	הרפס סימפלקס
במסגרת מתקדמות אמהות הנגועות ב-HIV צריכת להימנע מהנקה	מכחת	HIV
חיסון נגד אדמת לאחר הלידה והמחלה עצמה לא צריכים למנוע מאמא להניק	מכחת	אדמת



* הפסיטיס C

* למרות נוכחות צהבת C בכמה דגימות של חלב אם, אין כל עדות שהנקה גורמת סיכון להדבקות בצהבת C, ולא דווח אף מקרה של הדבקה מאם לתינוק דרך חלב אם. שיעור ההדבקה מאם לתינוק של צהבת C בתינוקות יונקים זהה לזה של תינוקות הנזונים מפורמולה ויש לאפשר לאמהות אשר תינוקותיהם נדבקו, להניק.

* שוער כי סדקים בפטמה מהנקה יכולים להוות סיכון להעברת צהבת C אך תאוריה זו היא היפותטית ולא מבוססת.

* התוצאה הבעייתית של המלצה זו היא שמשמעותה היא אין הנקה אם לאמא יש צהבת C, מכיוון שנשים כה רבות חוות טראומה זמנית לפטמה לאחר הלידה.